TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

HỘI THẢO

"Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng"

TUẦN 4

Trách nhiệm - Chất lượng - Phát triển - Hội nhập
Responsibility - Quality - Development - Integration

TUẦN 4
5/3/2022

CÁC BƯỚC ÁP DỤNG EBP TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

PGS.TS.BS.PHẠM LÊ AN
CNĐD. MAI NGUYỄN THANH TRÚC

Mục tiêu

- Mô tả quá trình áp dụng EBP trong thực hành lâm sàng
- Hiểu thành phần của câu hỏi lâm sàng dạng PICO(T) và chiến lược tìm kiếm
- Xác định các bằng chứng cho câu hỏi PICO(T)

Xây dựng câu hỏi lâm sàng



- Là phần quan trọng và “xương sườn” của quá trình áp dụng EBP trong thực hành lâm sàng và giảng dạy
- Bệnh nhân và các vấn đề liên quan là “điểm bắt đầu”
- Đặt câu hỏi mỗi lần gặp bệnh nhân
- Có thể là phần khó nhất

Xây dựng câu hỏi lâm sàng

❑ Câu hỏi độ nhạy cao (Background Question)

1. Kiến thức tổng quát về bệnh lý, vấn đề của bệnh nhân
2. Từ để hỏi: Ai, Thế nào, Cái gì, ….+ Động từ để hỏi
3. 1 rối loạn/triệu chứng/tình trạng bệnh nhân
4. Là nền tảng xây dựng câu hỏi đặc hiệu cao

❑ Câu hỏi đặc hiệu cao (Foreground Question)

1. Kiến thức chuyên ngành/chuyên biệt về một bệnh lý nào đó
2. Cấu trúc câu hỏi gồm nhiều thành phần
3. PICO(T), PIOM

Xây dựng câu hỏi lâm sàng

❑ Câu hỏi độ nhạy cao:

“Chỉ định mổ lấy thai cho những sản phụ nào?”

“ Nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa trên?

“ Nguyên nhân chuyển dạ đình trệ là gì?”

“ Biến chứng gì nếu không kiểm soát tốt tình trạng THA”

Xây dựng câu hỏi lâm sàng

❑ Câu hỏi đặc hiệu cao:

“Ở trẻ em, acetaminophen ảnh hưởng như thế nào đến cơn sốt trong vòng 30 phút sau khi dùng so với ibuprofen”

“Ở những bệnh nhân hội chứng ARDS, tư thế nằm sấp so với nằm ngửa ảnh hưởng như thế nào đến nhịp tim và độ bão hòa oxy sau khi thay đổi tư thế”

Câu hỏi PICO(T)

- Là câu hỏi nền tảng yêu cầu cần phải có kiến thức cụ thể để tích hợp với kinh nghiệm lâm sàng và tình trạng bệnh nhân
- **Cấu trúc:**

- ***P (Problem/Population):*** Vấn đề/Đối tượng
- ***I (Intervention/Issue):*** Can thiệp/Vấn đề quan tâm trên bệnh nhân
- ***C (Comparison/Control):*** So sánh
- ***T (Timeframe):*** Khung thời gian

Câu hỏi PICO(T)

- **P (Problem/Population):** Mô tả vấn đề/đối tượng
- **I (Intervention/Issue):** Mô tả các can thiệp/vấn đề quan tâm trên bệnh nhân, có thể là phương pháp điều trị/kế hoạch chăm sóc
- **C (Comparison/Control):** So sánh giữa nhóm áp dụng can thiệp và nhóm không thực hiện, có thể có hoặc không
- **O (Outcome):** Kết quả/Mục tiêu thực hiện can thiệp
- **T (Timeframe):** Thời gian thực hiện

Phân loại câu hỏi PICO(T)

- **Can thiệp (Intervention):** Các câu hỏi liên quan đến điều trị, bệnh lý
- **Căn nguyên (Etiology):** nguyên nhân gây ra bệnh lý, tình trạng của bệnh nhân

  Ví dụ: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng loét tỳ đè của bệnh nhân
- **Tiên lượng (Prognosis):** sự tiến triển của căn bệnh đang điều trị

  Ví dụ: Kết quả có thể mong đợi từ việc điều trị hoặc can thiệp được sử dụng

Phân loại câu hỏi PICO(T)

- **Chẩn đoán (Diagnosis):** quá trình xác định một bệnh hoặc tình trạng

-> Là cơ sở để đưa ra quyết định chăm sóc, điều trị chính xác nhất

Ví dụ: *Tình trạng của bệnh nhân là gì?*

- **Liệu pháp (Therapy):** can thiệp giúp cải thiện quá trình chăm sóc

Ví dụ: Điều trị nào thích hợp nhất với bệnh lý này? Kế hoạch chăm sóc nào thích hợp nhất với bệnh lý này?

Vai trò câu hỏi PICO(T)

- Cung cấp một cách nhất quán và hệ thống để xác định các thành phần của một vấn đề lâm sàng
- Giúp làm rõ các thông tin cần tìm kiếm
- Câu hỏi PICO(T) được xây dựng tốt làm tăng khả năng tìm kiếm bằng chứng tốt nhất một cách nhanh chóng và hiệu quả

Câu hỏi PICO(T)

1. **Ở bệnh nhân cao tuổi đang điều trị nội trú, tỷ lệ té ngã giữa nhóm bệnh nhân áp dụng chương trình phòng ngừa té ngã và không áp dụng trong 01 năm?**
2. **Làm thế nào để các bà mẹ mới sinh có các biến chứng liên quan đến vú nhận thức như thế nào về khả năng cho con bú của họ trong 3 tháng đầu sau khi sinh con của họ?**

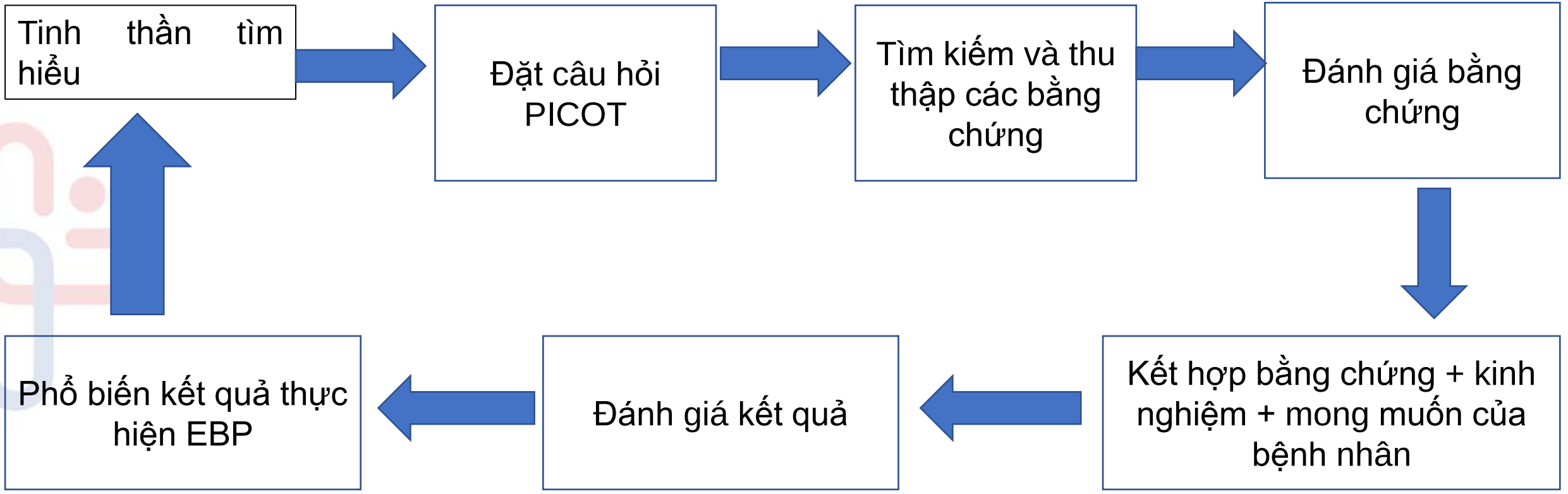
-> *Xác định các thành phần của câu hỏi PICO(T)*

Câu hỏi PICO(T)

Giảng viên tìm các phương pháp để dạy sinh viên cách hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc bệnh lý đái tháo đường trong 2 tháng chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội tiết?

-> Xây dựng câu hỏi PICOT

CÁC BƯỚC ÁP DỤNG EBP



Bước 0: Tinh thần tìm hiểu

"*Think about these clinical questions when caring for your patients. Ask why?...what am I doing what I am doing with my patients. Where can I find the best evidence to answer my clinical questions*"

(Melnyk, 2010)

Bước 0: Tinh thần tìm hiểu

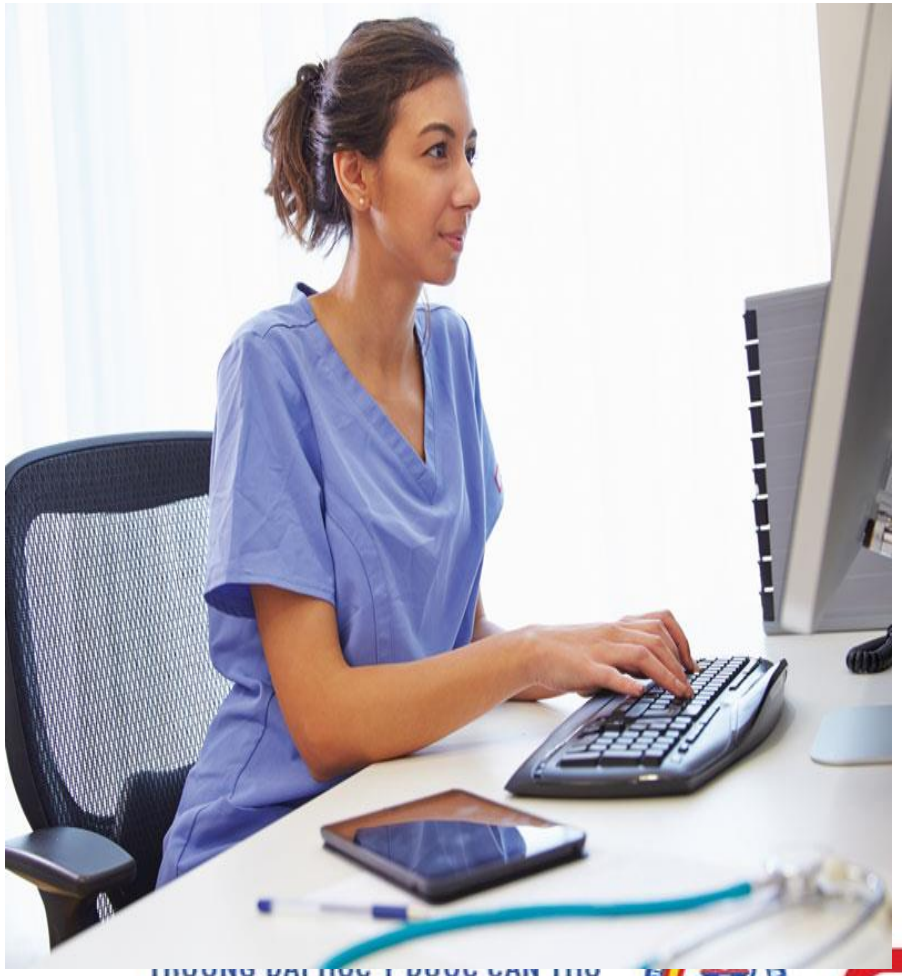
* Chiến lược để thúc đẩy EBP

- Tích hợp chiến lược sử dụng EBP vào sứ mệnh và triết lý của tổ chức
- Cam kết cùng thực hiện
- Tích hợp trong toàn bộ tổ chức
- Tạo môi trường thúc đẩy tư duy phản biện, tự chủ đưa ra quyết định
- Chia sẽ kinh nghiệm
- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá

Bước 0: Tinh thần tìm hiểu

"Without a culture and environment that is supportive of a spirit of inquiry and EBP, individual and organizational EBP change efforts are not likely to succeed and be sustained"

(Melnyk, 2016a)



Bước 0: Tinh thần tìm hiểu

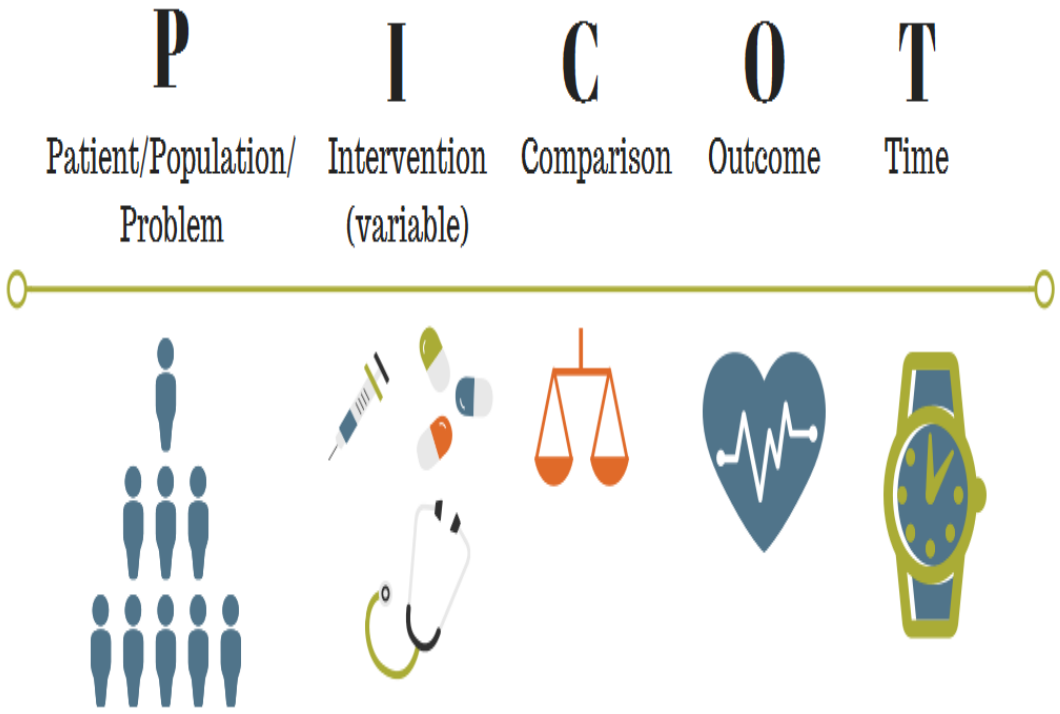
*** Yếu tố ảnh hưởng:**

- Tinh thần học hỏi, sáng tạo
- Cơ chế khuyến khích áp dụng EBP, quy trình đánh giá và kết hợp năng lực EBP
- Đối ngũ cố vấn về EBP
- Cơ sở vật chất, đội ngũ hỗ trợ thực hiện NCKH
- Cơ chế quản lý
- Làm việc đội nhóm, phối hợp liên ngành

Bước 1: Đặt câu hỏi PICOT

"Questions asked in a PICOT format result in an effective search that yields the best, relevant information and saves an inordinate amount of time"

(Melnyk & Fineout-Overholt, 2015)



Bước 1: Đặt câu hỏi PICOT

Khi một vấn đề có nhiều câu hỏi nên chọn câu hỏi liên quan đến kết quả quan trọng nhất hoặc thường gặp nhất

1. Ở bệnh nhân người lớn sau phẫu thuật, morphin so với hydromorphone ảnh hưởng như thế nào đến việc giảm đau trong vòng nửa giờ đầu sau khi dùng?
2. Ở bệnh nhân người lớn sau phẫu thuật, đi bộ hàng ngày so với không đi bộ hàng ngày như thế nào để ngăn ngừa vết loét do tì đè trong thời gian nằm viện?

-> Vấn đề phổ biến và ưu tiên: giảm đau

Bước 2: Tìm kiếm và thu thập các bằng chứng

"The type of study that would provide the best answer to an intervention or treatment question would be systematic reviews or meta-analyses, which are regarded as the strongest level of evidence on which to base treatment decisions"

(Melnyk & Fineout-Overholt, 2015)

Bước 2: Tìm kiếm và thu thập các bằng chứng

- Dựa trên câu hỏi PICOT đã xây dựng
- Xác định từ khóa và thuật ngữ từ câu hỏi PICOT
- Xác định tiêu đề, chủ đề
- Kết hợp các tiêu đề và từ khóa để thu hẹp hoặc mở rộng nội dung tìm kiếm
- Đánh giá kết quả tìm kiếm
- Chỉnh sửa/Tìm kiếm lại dựa trên kết quả đánh giá

Bước 2: Tìm kiếm và thu thập các bằng chứng

- **Câu hỏi độ nhạy cao:** Giáo trình, sổ tay hướng dẫn, các cơ sở dữ liệu
- **Câu hỏi đặc hiệu cao:** mức độ cao nhất của bằng chứng nghiên cứu có sẵn để trả lời

Bước 3: Đánh giá bằng chứng

*** Tiêu chí đánh giá:**

- **Tính hợp lệ**
  - Kết quả bằng chứng cung cấp có phù hợp với vấn đề lâm sàng?
  - Bằng chứng có được thực hiện bằng thiết kế nghiên cứu tốt hoặc phù hợp không?
- **Độ tin cậy**
  - Đã được thực hiện trên nhóm bệnh nhân cụ thể chưa?
  - Kết quả mang lại có đạt yêu cầu không?

Bước 3: Đánh giá bằng chứng

❑ **Khả năng ứng dụng**

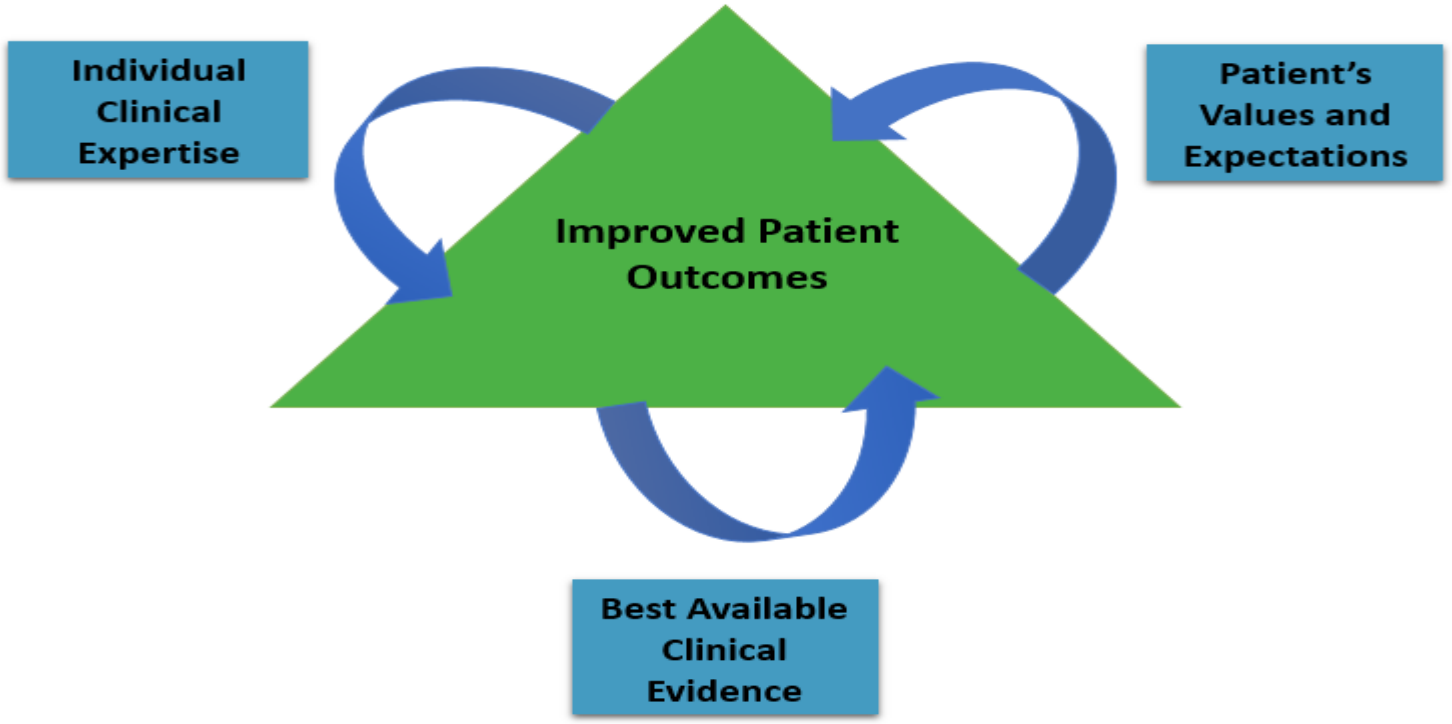
- Đối tượng nghiên cứu có thích hợp với bệnh nhân?
- Lợi ích nhiều hơn rủi ro
- Bệnh nhân mong muốn được áp dụng

- > Áp dụng GRADE system đánh giá phân loại

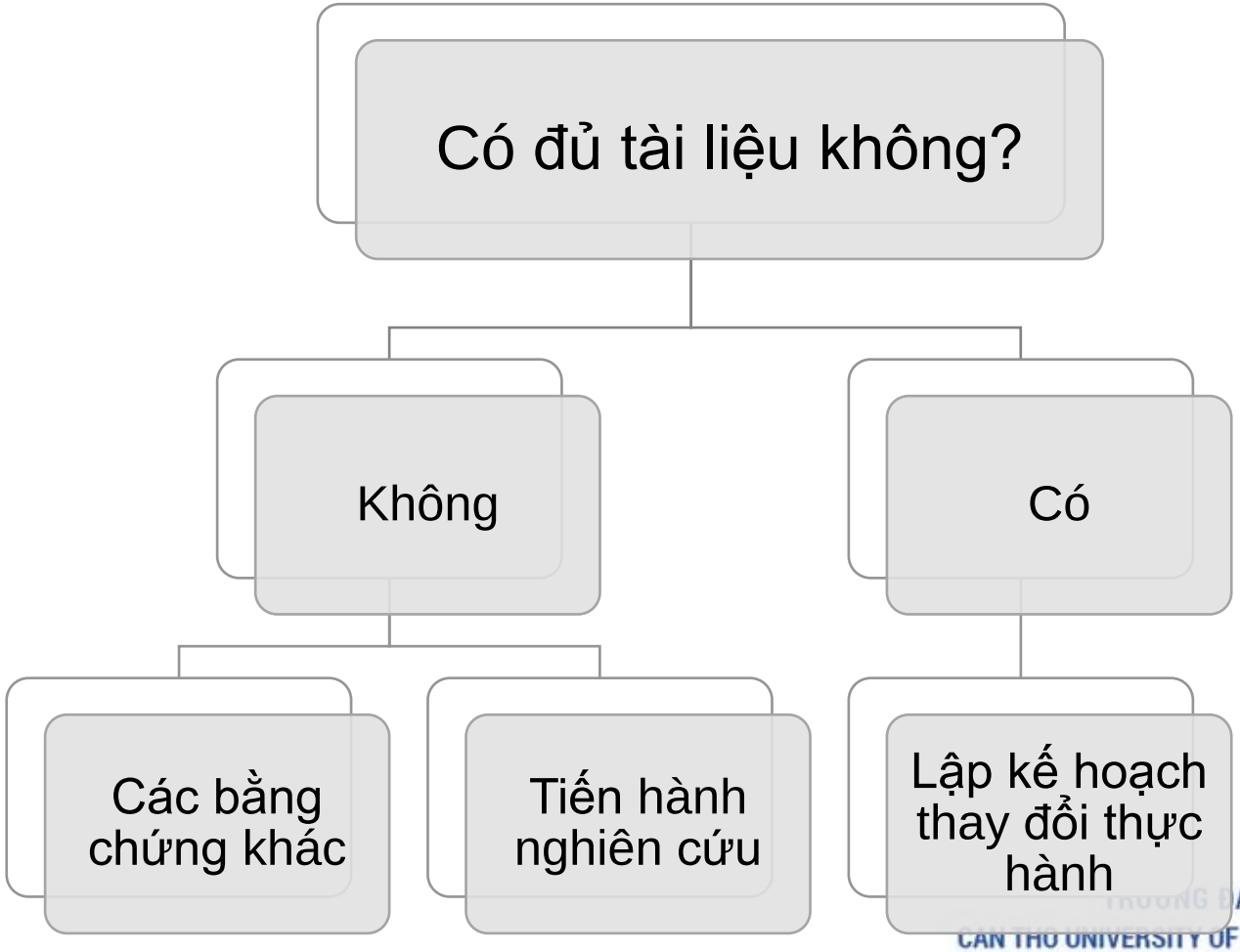
Bước 4: Áp dụng vào thực hành

"*Research evidence alone is not sufficient to justify a change in practice*"

(Melynk, 2010)



Bước 4: Áp dụng vào thực hành



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Bước 4: Áp dụng vào thực hành

1. Xác định kế hoạch dự án
2. Xác định phương thức thực hiện (sẽ thay đổi vấn đề gì)
3. Xây dựng công cụ đo lường kết quả
4. Xác định phương pháp thu thập số liệu
5. Thực hiện quy trình
6. Rút ra kết luận: chấp nhận – từ chối – sửa đổi thay đổi

Bước 5: Đánh giá kết quả

- Đánh giá quá trình thực hiện hoặc đổi dựa trên bằng chứng
- Trả lời các câu hỏi:
  - Đã thực hiện được những gì so với kế hoạch đặt ra?
  - Có điều gì xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình thay đổi không?
- Đánh giá kết quả trong các tổ chức CSSK
- Đánh giá mức độ phối hợp chăm sóc liên ngành

Bước 6: Phổ biến kết quả thực hiện

"*It only takes one passionate, committed person to spearhead a team vision to improve care for patients and their families*"

"*Developing a care of EBP mentors system-wide is key to the ongoing implementation and sustainability of EBP in an organization*"

(Melnyk, 2011)

Bước 6: Phổ biến kết quả thực hiện

- Cung cấp thông tin đến các đối tượng/nhóm liên quan
- Phổ biến bằng các phương pháp khác nhau
- Lồng ghép EBP về chính sách của cơ sở chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo văn hóa sử dụng EBP sử dụng kết hợp với ARCC Model

Bước 6: Phổ biến kết quả thực hiện

"*Dissemination of evidence - based practice results involves targeted circulation of information and interventions to a particular public health or clinical practice audience*"

(Choi, 2005)

"*The main objective of dissemination is to increase and promote the spread of knowledge regarding evidence - based interventions, with an intention of enhancing its greater application and patient outcomes*"

(Cain & Mittman, 2012)

Bước 6: Phổ biến kết quả thực hiện



The SHARE Approach

5 Essential Steps of Shared Decision Making



Bước 6: Phổ biến kết quả thực hiện

"*Healthcare audience is mostly interested on how specific evidence fit into a specific context and the implications of adopting the changes on various aspects, such as policy, quality of care, staffing and funding among other aspects*"

(Cain & Mittman, 2012)



DEPOT

Dissemination of Evidence into Practice: Opportunities and Threats

Author: Nicki Walsh (MSc, BSc Hons, RN, RNDN) Lecturer in Adult Nursing –

Abstract

AIM
To explore primary care nurses' (i.e. those delivering care outside the hospital environment) perceptions of issues that affect the dissemination and implementation of evidence-based nursing practice (EBP).

Background
Changes in society and the political landscape all influence healthcare service provision. These are complex and in a constant state of flux. Those providing services need to be flexible and adaptable to accommodate these changes. Maintenance and enhancement of knowledge is the cornerstone of any service development. This research explores the impact this knowledge maintenance and development requirement has within the daily clinical practice of nurses within a Community Nurse setting. It reviews issues that affect the dissemination and utilisation of evidence used to inform and enhance clinical practice.

Method
A combination of a positivist approach using quantitative methods alongside a more naturalistic approach using qualitative methods. A postal questionnaire was used to explore the views of all community nurses within one Primary Care Trust. This was supported with semi-structured interviews of four voluntary team leaders, following an open postal invite.

Findings
Both qualitative and quantitative results reveal consistency in identification issues that affect the effective implementation and utilisation of evidence in the practice setting. Workload pressures were considered fundamental in creating barriers to effective EBP. The context of these were variable. However, general consideration found that time was a factor alongside organisational issues such as protocol development, staffing structures and educational opportunities.

Conclusion
Primary/community care is a complex area of nursing, influenced constantly by many varying factors. EBP is seen as fundamental in the provision of high quality care and therefore all nurses and healthcare providers need to ensure that this is central to their delivery philosophies. This may mean review of organisational procedures alongside working practices.

Keywords: Evidence based-practice, community nursing, dissemination and utilisation

Introduction

- **WHY?** Changes in society and the political landscape influence healthcare delivery.
- These can be complex and in a constant state of flux, providing daily challenges to those working within healthcare.



- Primary /Community Care reform has been at the forefront of these changes. Current policy drivers reflect a political ideology, which embraces more competitive healthcare provision through Practice Based Commissioning (DH, 2005 a & b, DH, 2006, Bosanquet, et al, 2007).

- **HOW?** As a result those providing services need to be flexible and adaptable in order to accommodate these changes, whilst ensuring that the care they provide maintains the quality expected by those using the services.

- **WHAT?** For this to be successful, it is essential that knowledge levels are maintained and enhanced, keeping up-to-date with the political, societal, economic and technological changes that affect care provision. EVIDENCE BASED PRACTICE supports this knowledge development resulting in improved quality of care.

- This study's focus looked at research evidence dissemination and utilisation in the practice setting, however it could be considered that other evidences such as audit results and political changes also meet the same barriers in practice translation. It explores the impact of issues that affect the dissemination and utilisation of evidence used to inform and enhance clinical practice. Front-line clinicians' opinions are sought, questioning what issues they believe impact on the effectiveness of evidence dissemination and utilisation and how this then impacts on the care they provide.

Acknowledgments

Judy Smith, (Research Manager) Lincolnshire PCT,

Literature Review



Initial search terms used: "evidence-based health care", "evidence-based medicine", "evidence-based practice" "evidence-based nursing". This strategy revealed in excess of 100,000 results. Databases used: Google scholar, Medline, BNI and CINHAL. The search covered global healthcare, in an attempt to gain a balanced view from across differing healthcare environments. Date limits were not used, as these may have constrained the retrieval of older, seminal texts, written prior to EBP becoming "vogue". The vastness of the retrieval was felt not to provide the comprehensive search required. A more refined search using key words/ phrases such as: "definition of Evidence-based Practice (EBP)", "utilization" and "dissemination", were used.

This refined search provided 118 articles, which were selected for appraisal. Due to the time consuming nature of appraisal, abstracts were obtained and any that directly related to the above criteria were selected. To aid further refinement, "nursing", "community care" and "primary care" were also used.

From this further search, 30 texts were selected, however, it became apparent that a more robust appraisal could be achieved by utilising the references within these selected texts,

Following the retrieval and appraisal of these texts, 20 were selected as being fundamental to the specific aims of the study and have therefore been considered as part of this literature review.

The foundation for the study was EBP. What is meant by EBP?

Definitions of EBP are varied and dependent on the context to which they relate. One of the mostly commonly cited definitions is Sackett et al,(1997) who regard EBP as a process that enables holistic and individualised care to be developed in a way that utilises current best practice.

It is worthy of note that much of the original work on EBP focuses on evidence-based practice within medicine, interest in this area gathered momentum following the conception of the phrase by a group led by Gordon Guyatt at McMaster university in 1992 (Straus, 2005). However, nursing's recent history shows a keen pursuit of medicine's adoption of evidence-based practice (Kitson, 2004). The rationale for some of this has been relates to the quality agenda and clinical governance.

The Royal College of Nursing (RCN), supports adoption of EBP and link their definition of EBP more directly with recent policy papers that have influenced the clinical uptake of EBP, for example the NHS Plan (2000), stating that Evidence-based practice is "doing the right thing in the right way for the right patient at the right time" (RCN, 1996).

> *"Evidence-based clinical practice (EBCP) is an approach to healthcare practice in which the clinician is aware of the evidence that bears on her clinical practice and the strength of that evidence"* (McMaster, 2007)

> *"Evidence-based clinical practice is an approach to decision making in which the clinician uses the best evidence available, in consultation with the patient, to decide upon the option which suits that patient best"* (Muir Gray, 1997).

Literature appraisal considered, perhaps a more sinister side of EBP, which relates to the stifling of innovative practice, through the power of knowledge (Foucault, 1990 and Traynor, 1999). This area explores how organizational and governmental rhetoric has become one of the key influences of clinical practice and perhaps this has happened under the pseudonym of quality.



Finally, other studies were critiqued.. Many (although not all) of these focused on negative elements or barriers of EBP utilization, often surmising about the opportunities. Many studies being set in an institutional setting.

Unfortunately, no conclusive results have been identified, however work by Kitson et al (1998) from the RCN institute demonstrates the development of a tool which could help facilitate EBP in practice, the PARIHS framework.

Method

A combination of approaches using quantitative methods alongside a more naturalistic approach using qualitative methods, have been used. This combination corresponds with the exploration of health care issues particularly well (Bowling, 2002). This concept, when discussed in relation to nursing, highlights the need to reflect on care delivery both from a scientific perspective and from an art perspective.

The tools used were a postal questionnaire for the quantitative section. This was sent to all community nursing staff in one Primary Care Trust (n88).

Results



Questionnaires

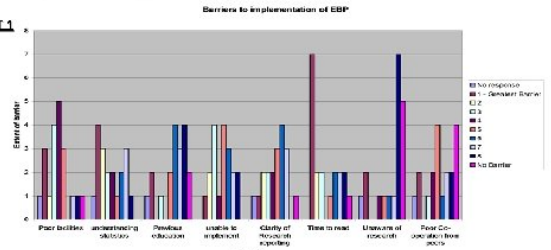
Pilots provided positive feedback of the questionnaire which had 14 questions quantitative in nature, one question which allows respondents the opportunity to express a more developed opinion.

19 questionnaires were returned, which was an extremely low response rate (21.5%). This was felt not to be significant enough to provide rich data, however acted as a "pointer" towards areas that might be discussed as part of the semi-structured interview.

Why such a low response rate? There are a variety of reasons why this low rate could have occurred. Primarily it was felt that organizational changes within the PCT had influenced this. Other reasons could relate to the topic area of EBP and its significance in the larger picture of clinical practice., or the "state of flux" that nursing and particularly community nursing finds itself in with regard to the value of clinical role.

Although the response rate was low, the primary barrier to EBP was considered to be time however the primary opportunity was the availability of evidence. (See Chart 1). This synopsis reflects conflict between quality care delivery and the ability to influence this. Time pressures through clinical need are potentially impacting on clinicians' ability to influence change.

CHART 1





Semi-structured interviews

These were analyzed using a constant, comparative method (Glaser & Strauss, 1967). Typed interview transcripts were used. These were visited repeatedly looking for emergent themes or codes, which were highlighted within the typed text. Data was revisited until no new emergent themes were identifiable. Areas to which several codes applied were discovered and this prompted consideration of a frequency chart, which looked at the frequency of occurrences of certain codes. Nolan and Behi (1995) feel that it is important to have a method of validity, which supports the subjective nature of coding and therefore it was felt that this would provide a useful exercise to the inexperienced researcher to consolidate code interpretation.

Emergent codes were: **Opportunities, Threats, Clinical Care** and **Facts**

Coding was undertaking using inductive reasoning and therefore 23 further sub codes were used. The result was that the four emergent theme were split into further categories depending on the prevalence of the sub code within the text.

Opportunities:
Education (28 occurrences) was considered synonymous with opportunity for EBP effectiveness. *Respondent 1 commented "personal development in nursing – you cannot stand still. It's the only way you can understand the best clinical practice".* This comment reflects the fundamental issue of Continuing Professional Development (CPD) and how this should be central to all organisational objectives which enhance quality.,

Threats
The most commonly occurring theme under threats was time. *Respondent 4: "I think the biggest thing, staffing levels, time, resources paper work and caseload figures".* It is interesting to note how staff feel that they are constrained by the clinical demands that are being made on them. Although, time (related to chronological time), could also reflect capacity in terms of number of team members and working practices, therefore time is a complex issue that demands careful consideration and effective planning measures to enhance effectiveness.

Clinical Practice
The respondents felt that pathways may provide consistent approach to care delivery, especially in view of the isolated

Discussion

The issues contributing to under utilisation of EBP are multifaceted and complex,



Bryar, et al, 2003). It has been the aim of this study to attempt to understand some of these issues and to discover what might help improve the dissemination and utilisation of Evidence-based Practice (EBP) in the Primary/Community healthcare setting, thus facilitating clinical effectiveness and higher quality of care.

Clinicians felt that time was the primary obstruction in dissemination and utilisation of EBP. This was multifaceted, but primarily:-

- the plethora of information
- the practice constraints placed upon clinicians

It could be argued that EBP is restrictive in terms of autonomous practice (Closs & Cheater, 1999), this relates to the issues identified within the findings of this study. It could be considered that organizational agenda has a significant influence on dissemination and utilization of EBP, dictated through protocol development under the guise of a mechanism that promotes quality, however this has the potential to stifles innovation. However, it could be argued that education can promote the ability to question practice and reassert clinicians' ability to challenge practice.

In Conclusion the issue of dissemination and utilization is as complex and fluctuating as the healthcare provision it is intended to support. Clinicians, organizations and government policy need to ensure that these complexities are account for in the policy developments they make as a result of attempting to improve the quality of healthcare provision.

Recommendations



It is acknowledged that this study has identified many complexities that relate to the dissemination and utilisation of evidence based practice in the community setting.

Education – Maintenance of skill levels through regular Continuous Professional Development (CPD) facilitated by initiatives such as the Knowledge and Skills Framework and appraisal mechanisms.

Nurse Education - A global response should reflect the needs of pre-registration students nurses and the need to impose upon them the importance of EBP in relation to effective clinical outcomes.

Time management skills facilitate effective EBP, these skills should be taught alongside the skills of analysis. Education could be introduced to look at these skills in relation to information cascade and skills required to read, critique and disseminate research.

Existing Systems - Utilisation of existing systems needs to be continued and outcomes monitored for effectiveness. This relates to the utilisation of specialist knowledge and link forums, which are already supported by organisations.

Communication - Lines of communication to be robust, monitored and evaluated. This also relates to organisational influence and responsibilities of the individuals. Each need to recognise their role and appreciate the roles of others.

Nursing as a Profession - Nursing to become more academic without losing its sights on what nursing is (the ART and SCIENCE of Nursing) Again this is a more global recommendation. However, through local processes such as appraisal and CPD this should be fundamental and become second nature to the nursing process, alongside the skills of caring.

References

1. DH (2005a), Department of Health (2005a) *Creating a Patient Led NHS: Delivering the NHS Improvement Plan.* London, Her Majesty's Stationery Office.
2. DH (2005b), Department of Health (2005b) *NHS Improvement Plan.* London, Her Majesty's Stationery Office.
3. DH (2006), Department of Health (2006) *Our health, our care, our say: a new direction for community services.* London, Her Majesty's Stationery Office.
4. Bosanquet, N., de Zoete, H. and Heldenby, A., (2007) *NHS Reform: The Empire Strikes Back.* London, REFORM
5. Sackett, D.L., Richardson, W.S., Rosenberg, W. and Haynes, R.B., (1997) *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM,* (1st Ed), Edinburgh, Churchill Livingstone
6. Straus, S.E., Richardson, W.S., Glasziou, P. and Haynes, R.B., (2005) *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM* (3rd Ed) Edinburgh, Churchill Livingstone.
7. Kitson, A., Harvey, G. and McCormack, B., (1998) Enabling the implementation of evidence based practice: a conceptual framework, *Quality Health Care*, Vol. 7 , No. 3, pp 149-158
8. McMaster University: http://hiru.mcmaster.ca/ebm/default.htm# *What_is_Evidence_Based_Medicine* Accessed on 30/08/06
9. Muir Grey JA. (1997) *Evidence-based healthcare: how to make health policy and management decisions*. London: Churchill Livingstone.
10. Foucault, M., (1980) *Power/knowledge*, Brighton, Harvester
11. Traynor, M. (1999), The problem of dissemination: Evidence and Ideology, *Nursing Inquiry*, Vol. 6, No. 3, pp 187-197

THANKS!



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

(84-0292) 3 739 730

ctump@ctump.edu.vn

ctump.edu.vn

179 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ